

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

DAST-10 · PRUEBA DE DETECCIÓN DE ABUSO DE DROGAS

Cribado estandarizado y cuantificación de la gravedad del consumo problemático de sustancias psicoactivas

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Drug Abuse Screening Test - Versión Corta de 10 ítems (DAST-10)
Autor Original	Harvey A. Skinner (1982) - Addiction Research Foundation (Toronto, Canadá)
Validaciones Hispanas	Bedregal et al. (2006) y Pérez-Gálvez et al. (2010)
Tipo de Instrumento	Autoinforme o cuestionario heteroaplicado estructurado de cribado
Población Diana	Adolescentes y adultos (>= 16 años) en atención primaria, urgencias y centros de adicciones
Tiempo de Aplicación	3 a 5 minutos (10 preguntas dicotómicas)
Formato de Respuesta	Dicotómico: Sí / No (referido a los últimos 12 meses)
Finalidad Clínica	Identificación rápida, cribado masivo y gradación de severidad del uso nocivo y dependencia de sustancias psicoactivas (excluyendo alcohol y tabaco)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El DAST fue formulado en 1982 por Skinner como un análogo del Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), pero orientado exclusivamente a evaluar las consecuencias y problemas derivados del uso de drogas ilícitas y psicofármacos utilizados sin prescripción médica o de forma recreativa (cannabis, cocaína, opioides, alucinógenos, sedantes, hipnóticos). La versión abreviada de 10 ítems (DAST-10) conserva las propiedades operativas del instrumento clásico de 20 y 28 reactivos, optimizando la factibilidad de su administración en servicios hospitalarios y de salud mental.

El constructo evaluado no es el consumo episódico per se, sino el patrón de afectación biopsicosocial: pérdida del control volitivo, repercusiones familiares y de pareja, problemas médicos o episodios de sobredosis/blackouts, conductas ilegales asociadas a la obtención de sustancias y síntomas físicos/psíquicos de abstinencia. Esta perspectiva dimensional permite segmentar la necesidad terapéutica desde la intervención preventiva hasta la hospitalización.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio Clínico	Nº Ítems	Ítems Constituyentes	Aspecto Conductual Específico
Uso No Médico y Policonsumo	2 ítems	1, 2	Consumo no médico y uso concurrente de múltiples sustancias.
Pérdida de Control	2 ítems	3, 4	Incapacidad para frenar el consumo y episodios de amnesia/lagunas.
Impacto Social e Interpersonal	3 ítems	5, 6, 7	Culpa individual, quejas de la pareja/familia y problemas laborales.
Consecuencias Médicas y Legales	3 ítems	8, 9, 10	Actividades delictivas, complicaciones médicas y síndrome de abstinencia.

Clave de corrección crítica: El ítem 3 ("¿Es capaz de dejar de consumir drogas cuando lo desea?") se puntúa en sentido inverso: la respuesta "No" otorga 1 punto. Todos los demás ítems puntúan 1 con "Sí".

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · DAST-10

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.86 a 0.90 en diversas poblaciones de habla hispana, demostrando excelente homogeneidad.
Sensibilidad y Especificidad	Con punto de corte ≥ 3 : Sensibilidad diagnóstica = 95%, Especificidad = 74%, ROC-AUC = 0.92 frente a criterios DSM-5 de Trastorno por Uso de Sustancias (TUS).
Validez de Criterio	Alta correlación con el Addiction Severity Index (ASI, $r = 0.76$) y concordancia elevada con determinaciones toxicológicas en orina.
Invarianza Transcultural	Consistencia psicométrica probada en muestras clínicas psiquiátricas y de atención primaria en España, México, Chile y EE. UU.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Regla de Asignación Dicotómica (0 o 1):**
 - Ítems directos (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): Sí = 1 punto, No = 0 puntos.
 - Ítem invertido (3: "¿Es capaz de dejar de consumir drogas cuando quiere?"): No = 1 punto, Sí = 0 puntos.
- Puntuación Total:** Suma de las respuestas afirmativas directas más el ítem 3 invertido.
- Rango de Puntuación:** De 0 a 10 puntos posibles.
- Condición de Aplicación:** Excluir explícitamente alcohol y nicotina del marco de respuesta; para alcohol debe usarse en paralelo el cuestionario AUDIT o CAGE.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Nivel de Riesgo	Grado de Afectación	Directriz Terapéutica Recomendada
0 puntos	Sin Problema	Ausente	No requiere intervención específica. Refuerzo positivo.
1 a 2 puntos	Nivel Bajo	Consumo de riesgo leve	Monitorización periódica y consejo preventivo breve.
3 a 5 puntos	Nivel Moderado	Abuso / TUS Leve	Intervención breve motivacional y evaluación diagnóstica.
6 a 8 puntos	Nivel Sustancial	TUS Moderado-Grave	Derivación formal a unidad especializada de conductas adictivas.
9 a 10 puntos	Nivel Severo	TUS Severo / Crónico	Evaluación médica intensiva y desintoxicación / internación.

UMBRAL DE INTERVENCIÓN CLÍNICA (DAST-10 ≥ 3): Una puntuación igual o superior a 3 puntos señala un uso clínicamente problemático que requiere valoración toxicológica formal. A partir de 6 puntos, el paciente presenta un patrón compulsivo con daño funcional severo que raramente responde a consejo médico aislado.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · DAST-10

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Cribado Sistemático: Administrar anualmente o ante sospecha diagnóstica en centros de salud y consultas de psiquiatría.

Paso 2: Segmentación Asistencial:

- **Puntuación 1-2:** Intervención Breve FRAMES (Feedback, Responsabilidad, Consejo, Menú de opciones, Empatía, Autoeficacia).
- **Puntuación 3-5:** Entrevista motivacional para el cambio (modelo Prochaska-DiClemente). Descartar patología dual (depresión, TDAH).
- **Puntuación >= 6:** Derivación a Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAD / UCA). Pautar toxicología en orina, serologías infecciosas (VIH, VHB, VHC) y valorar apoyo psicofarmacológico específico (sustitutivos opioides, anticraving).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 31 años, cocinero en hostelería, acude a urgencias con cuadro de crisis de pánico aguda y taquicardia sinusal. Durante la anamnesis refiere consumo recreativo ocasional.

Evaluación Psicométrica Inicial: DAST-10 = 7 / 10 puntos (Riesgo Sustancial de Abuso de Drogas).

- Admite policonsumo habitual de clorhidrato de cocaína y cannabis (Ítems 1 y 2 = Sí).
- Reconoce incapacidad manifiesta para frenar el consumo los fines de semana (Ítem 3 = No -> 1 punto).
- Reporta quejas graves de su pareja, problemas para llegar al trabajo en horario matutino y temblores de abstinencia (Ítems 5, 7 y 10 = Sí).

Intervención: El resultado del DAST-10 permitió visibilizar ante el paciente la gravedad real de su conducta, desmantelando la minimización ("sólo consumo para aguantar el ritmo"). Se inició intervención motivacional ambulatoria en coordinación con la Unidad de Conductas Adictivas, pautándose tratamiento cognitivo-conductual de prevención de recaídas y detección de disparadores ambientales. A los 6 meses de seguimiento, con analíticas toxicológicas negativas continuadas, el DAST-10 se redujo a 0 puntos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Respuestas positivas al ítem 10 (síntomas de abstinencia) en consumidores de benzodiacepinas u opioides exigen supervisión médica inmediata por riesgo de convulsiones o síndrome confusional.
- Puntuaciones >= 8 se asocian a un riesgo significativamente elevado de sobre-dosis y conductas delictivas de subsistencia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y COMORBILIDAD

- **Patología Dual:** Investigar comorbilidad con TDAH no diagnosticado, trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad.
- **Uso iatrogénico:** Diferenciar entre adicción primaria y dependencia física por prescripción crónica de opioides o hipnóticos en dolor crónico.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Skinner, H. A. (1982). The drug abuse screening test. *Addictive Behaviors*, 7(4), 363–371.
- Bedregal, L. E., Sobell, L. C., Sobell, M. B., & Simco, E. (2006). Psychometric characteristics of the Drug Abuse Screening Test (DAST-10) in a Spanish-speaking population. *Addictive Behaviors*, 31(12), 2209–2219.
- Pérez-Gálvez, B., García-Fernández, L., De Vicente-Manzanaro, M. P., & Skinner, H. A. (2010). Validación española de la prueba de detección de abuso de drogas (DAST-10). *Adicciones*, 22(3), 247–254.
- Yudko, E., Lozhkina, O., & Fouts, A. (2007). A comprehensive review of the psychometric properties of the Drug Abuse Screening Test. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 32(2), 189–198.